ASESORÍA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTENIDO PÚBLICO

Plan estratégico: sustento sanitario, territorial y relato político para el décimo CESFAM

Bases técnicas para la instalación pública de la demanda comunal y conducción de la iniciativa desde la concejalía

1. LA DISPUTA DEL RELATO: DE LA DEMANDA TESTIMONIAL A LA OFENSIVA SANITARIA

Instalar con éxito una demanda social en el debate comunal exige superar la denuncia puramente reactiva o testimonial. En La Florida, la necesidad de un décimo Centro de Salud Familiar (CESFAM) suele abordarse desde la queja cotidiana por las filas de madrugada, diluyéndose en disputas menores de gestión con la administración local. Esta propuesta tiene como fin articular un **sustento técnico riguroso que fundamente la urgencia sanitaria comunal y sitúe a la concejalía como punta de lanza institucional**, dotando a la demanda de un marco de movilización ciudadana y masividad popular para exigir la solución definitiva.

> **Enfoque estratégico:** Los datos duros no deben quedar enclaustrados en debates técnicos ni informes burocráticos. La narrativa comunicacional opera como el puente entre la evidencia demográfica y la vivencia territorial de las familias. Demostramos que la red colapsó porque la comuna creció y envejeció sin inversión proporcional, transformando el décimo CESFAM en una causa común de dignidad y derecho a la salud.

2. MATRIZ DE INDICADORES DUROS Y BRECHA DE CAPACIDAD INSTALADA

Variable / Fuente	Dato comunal	Traducción sanitaria y política
Población total	374.836 hab. (Censo 2024)	4.ª comuna más grande de Chile; alta presión sobre la infraestructura existente.
Padrón FONASA APS	345.649 personas inscritas	92,2% de la comuna depende de la atención primaria municipal administrada.
Capacidad por centro	38.400 inscritos promedio	Supera con creces el estándar ministerial resolutivo (20 a 30 mil hab. por centro).
CESFAM Bellavista	51.786 inscritos validados	Caso más crítico comunal: supera en más de 2,5 veces la capacidad técnica recomendada.
Índice adultos mayores	103,4 (60.747 hab. ≥65 años)	Envejecimiento acelerado: 103 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años.
Mortalidad infantil	6,0 por 1.000 nacidos vivos	Superior a la RM (5,4) y Chile (5,9); evidencia falta de cobertura preventiva materno-infantil.

3. TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA: CRONICIDAD Y CAMBIO EN EL PERFIL DE DEMANDA

El argumento epidemiológico más contundente para justificar el décimo centro radica en el envejecimiento acelerado de La Florida. Entre 2017 y 2024, la población mayor de 65 años creció en 13.657 personas (+29%), alcanzando el 16,2% de los vecinos. Este fenómeno no es abstracto: altera por completo el modelo de atención requerido. La demanda principal ya no es el episodio infantil agudo, sino la atención continua de patologías crónicas no transmisibles (hipertensión, diabetes, afecciones osteomusculares y deterioro neurocognitivo).

Este perfil exige controles médicos programados, seguimiento farmacológico estricto, visita domiciliaria a personas con dependencia severa y rehabilitación física comunitaria. Cuando una red opera al 150% de su capacidad, el seguimiento crónico se fractura, provocando descompensaciones que saturan los servicios de urgencia hospitalaria y deterioran gravemente la calidad de vida de las familias floridanas.

4. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DESMITIFICACIÓN DE LOS “DISPOSITIVOS PARCHE”

Frente al colapso de las horas de atención, la gestión municipal ha respondido recurrentemente con operativos extraordinarios de fin de semana y descansando en dispositivos secundarios como SAPU o CECOSF. Si bien estas medidas alivian el síntoma urgente de corto plazo, **constituyen una respuesta paliativa que elude la solución de fondo**.

> **Diferenciación conceptual para el debate público:** Un SAPU o un operativo móvil atiende la crisis episódica o el síntoma puntual. Un CESFAM, en cambio, asegura controles preventivos periódicos, salud mental comunitaria, vacunación, tamizaje precoz y acompañamiento integral a lo largo del ciclo vital. Sustituir un consultorio definitivo por parches asistenciales encarece el gasto público y condena a las comunidades a vivir en permanente precariedad sanitaria.

5. FRACTURA SOCIOESPACIAL: BARRIOS DESCONECTADOS Y SOBRECARGA LABORAL

La expansión demográfica e inmobiliaria experimentada por La Florida no fue acompañada de la reserva oportuna de suelo público ni de la construcción de infraestructura sanitaria equivalente. Esto ha provocado dos nudos críticos:

- **Barreras de acceso y movilidad en sectores periféricos:** En zonas altas y sectores sur de la comuna, adultos mayores y cuidadoras deben invertir hasta dos horas entre trayecto de ida y vuelta y esperar desde las 5:00 AM para asegurar un cupo de atención, lo que constituye un trato indigno hacia la ciudadanía.
- **Desgaste y agotamiento de los equipos clínicos:** La sobrecarga no solo vulnera al paciente; impacta directamente a funcionarios y funcionarias de la salud municipal, sometidos a niveles intolerables de estrés laboral y frustración por la carencia crónica de box e insumos.
- **Agudización de listas de espera secundarias:** La falta de contención resolutiva en la atención primaria traslada artificialmente la demanda al Hospital Dra. Eloísa Díaz, agravando las listas de espera de especialistas en el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO).

6. VIABILIDAD INSTITUCIONAL: TERRENO MUNICIPAL Y FONDOS SECTORIALES

El financiamiento de un décimo CESFAM no depende del presupuesto corriente comunal. Los recursos para infraestructura de salud provienen de convenios de programación del Ministerio de Salud (MINSAL), del SSMSO y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del GORE Metropolitano.

La verdadera traba histórica ha sido la **falta de voluntad política local para identificar, adquirir y comprometer el terreno**, además de la ausencia de un proyecto técnico ingresado formalmente al Banco Integrado de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF). Es en este punto ciego donde la concejalía debe concentrar su interpelación.

7. EL ENJAMBRE DE MEDIOS: CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISPUTA TERRITORIAL

Para que los argumentos técnicos no queden aislados en un documento estático, **hay que operar bajo la lógica de un enjambre de medios articulado en régimen continuo**. Cada soporte cumple una función diferenciada dentro de una cadena de producción que amplifica la demanda territorial hacia el debate público (el detalle operativo y parámetros de realización se desglosan en anexo técnico):

1. Minuta técnica de fiscalización (soporte base): Documento formal de fundamentación sanitaria ingresado al Concejo Municipal y entregado a gremios de salud (Confusam). Fija el estándar técnico de la brecha y formaliza las solicitudes a los órganos pertinentes.

2. Píldoras audiovisuales verticales (redes): Cápsulas ágiles de 45 segundos orientadas a plataformas móviles (Reels / TikTok). Sintetizan los datos de saturación en clave directa y activan el llamado ciudadano a sumarse al proceso de organización comunal.

3. Ficha de síntesis territorial (WhatsApp): Resumen infográfico de una página optimizado para teléfonos móviles. Diseñado para circulación en redes de organizaciones sociales, juntas de vecinos y comités barriales sin barreras técnicas de descarga.

4. Repositorio abierto y padrón de adhesión (QR): Plataforma web de legitimidad que centraliza los informes técnicos y aloja un formulario digital de firmas ciudadanas, enlazado en volantes y afiches impresos para respaldar el petitorio ante el municipio.

5. Diálogos territoriales y registro testimonial: Espacio de conversación en audio y video con representantes vecinales, dirigentes de la salud y usuarios del sistema, registrando las brechas territoriales reales de cada sector de la comuna.

6. Protocolo de incidencia en prensa y coyuntura: Mecanismo de respuesta rápida (menor a 24 horas) para emitir posicionamientos, cartas a medios regionales y notas informativas ante contingencias sanitarias o anuncios de la administración comunal.

8. CONDUCCIÓN POLÍTICA, ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y MASIVIDAD SOCIAL

La viabilidad del décimo CESFAM no depende únicamente de la solvencia de sus cifras, sino de la capacidad de articular una fuerza comunitaria amplia que haga suya esta necesidad. En este esquema, la concejalía actúa como punta de lanza institucional abriendo los espacios de debate y fiscalización, mientras que la conducción política y la articulación de vocerías responderán a la dinámica y maduración de la propia organización territorial. El propósito central es dotar a la demanda de arraigo popular y masividad.

La salud pública digna no es una concesión administrativa: es un derecho fundamental que se conquista transformando la evidencia técnica en fuerza colectiva y organización barrial permanente.

José Escárate Leyton
Periodista | Comunicación estratégica y narrativa digital
Octubre de 2026